HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ



Хеликобактер пилори: что с ней делать



Helicobacter pylori (H. pylori) — спиралевидная бактерия, живёт и размножается в слизистой оболочке желудка и верхней части тонкой кишки. Может выживать в кислой среде желудка, вырабатывая фермент уреазу, который нейтрализует желудочную кислоту вокруг неё.



HOLISTICA DOC

Встречается у более чем 60 % населения Земли. Может обитать в организме бессимптомно всю жизнь. У 70 % носителей не вызывает заболеваний — это зависит от:

- штамма *H. pylori*
- иммунитета
- генетики
- образа жизни, снижающего защитные факторы слизистой: стресс, курение, приём НПВС и пр.

У некоторых людей *H. pylori* может положительно влиять на иммунный ответ и снижать риск пищевых аллергий.

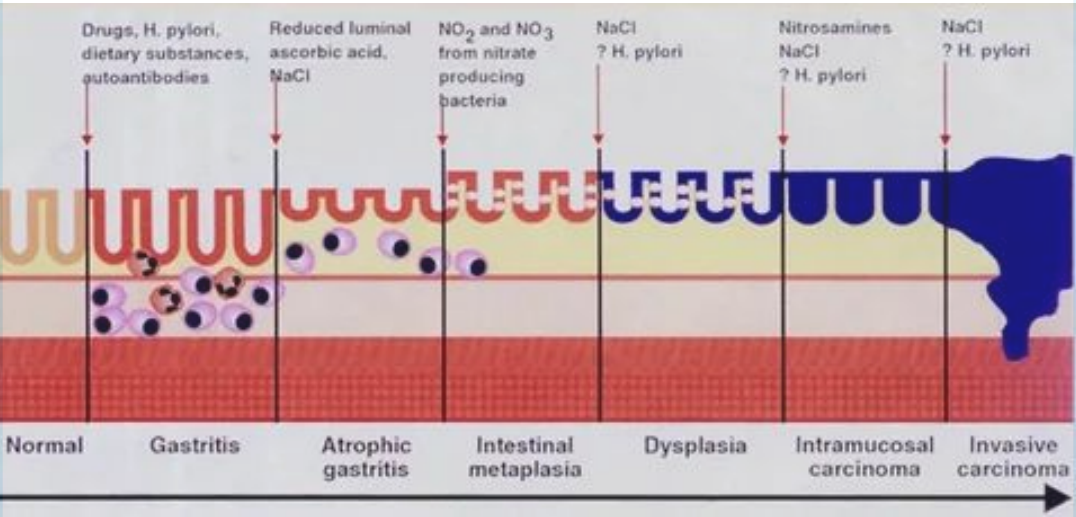


Патогенные штаммы *H. pylori*

- Разрушают защитный муциновый слой желудка, делая стенки уязвимыми для соляной кислоты
- Вызывают воспаление – гастрит, часто бессимптомный → при длительном воспалении нарушается выработка HCl
- Повреждают клетки желудка и двенадцатиперстной кишки, провоцируя эрозии и язву
- Хр. гастрит может сформировать атрофический гастрит → может перейти в метаплазию и онкологическое перерождение клеток
- Могут быть причиной аденокарциномы желудка и MALT-лимфомы

Патогенные штаммы *H. pylori*

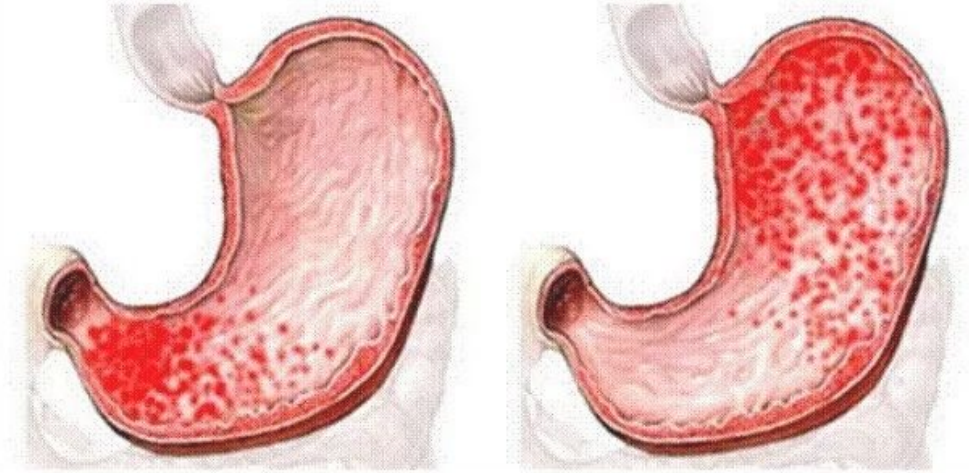
- Могут вытеснять другие бактерии и влиять на флору всего ЖКТ
- Некоторые штаммы устойчивы к антибиотикам



HOLISTICA DOC

Однако! *H. Pylori* – не единственная причина гастрита, язвенной болезни желудка и онко. Это всегда совокупность факторов: генетика, дисфункция нервной системы, снижение защитных факторов слизистых, иммунный ответ и т. д.

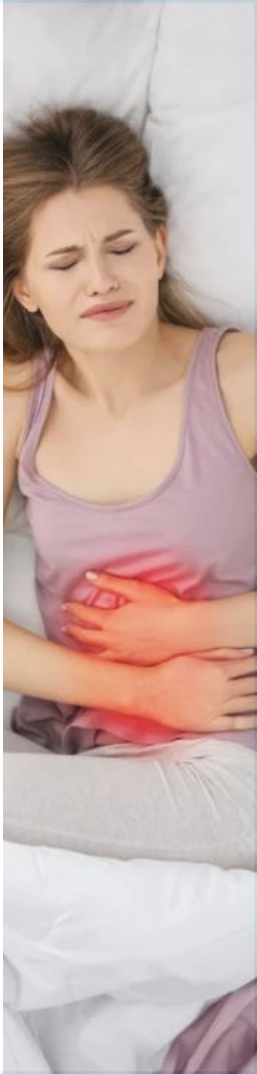
К примеру, длительный прием ИПП приводит к распространению *H. Pylori* из антрального отдела в тело желудка, вызывая гастрит.



Диагностика

В каких случаях нужно обследование на *H. pylori:*

- диспепсия неясного генеза
- хронический гастрит
- язвы желудка или двенадцатиперстной кишки (в анамнезе или настоящие). Более 90 % язв двенадцатиперстной кишки и до 70 % язв желудка связаны с *H. pylori*. Диагностика и последующее лечение — стандарт гастроэнтерологии
- атрофический гастрит, метаплазия или дисплазия (по результатам гастроскопии). При подтверждении *H. pylori* — эрадикация!



HOLISTICA DOC

Диагностика

В каких случаях нужно обследование на *H. pylori:*

- близкие родственники с раком желудка
- анемия неясного генеза
- идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
- планирование длительного приёма НПВС / аспирина / антикоагулянтов (повышают риск эрозий и инфицирования *H. pylori*)
- повторное инфицирование или неэффективность прошлой терапии *H. pylori*. Расширенные тесты: ПЦР, посев, определение устойчивости к антибиотикам



Виды диагностики *H. pylori*

Известны 370 штаммов *H. pylori.* Почему важно знать штамм?

CagA+	Связан с язвами, атрофией, раком желудка
CagA–	Менее патогенен, может быть бессимптомным
VacA s1/m1	Вызывает воспаление
Штаммы с мутациями	Устойчивость к антибиотикам

Дыхательный уреазный тест (13C)

Что показывает:

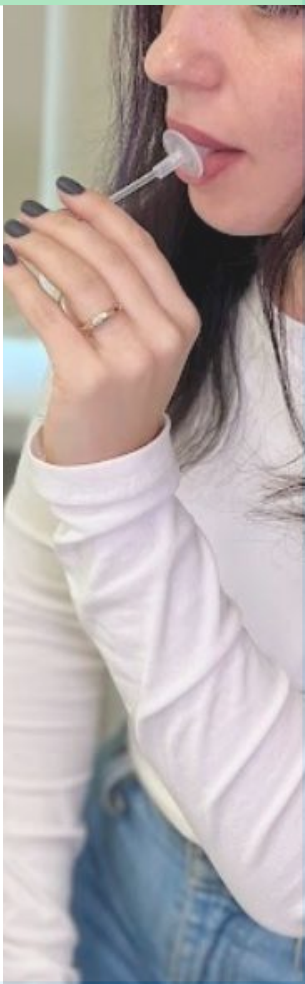
✓ наличие активной *H. pylori* в желудке (расщепляет мочевину до CO_2)

Что НЕ показывает:

- степень воспаления или повреждение слизистой
- не определяет штамм (CagA, VacA)
- не определяет чувствительность к антибиотикам

Когда использовать:

- для первичной диагностики
- после лечения – для проверки эффективности эрадикации (через ≥ 4 недели)



HOLISTICA DOC

Анализ кала на антиген *H. pylori* (иммунохроматография или ИФА)

Что показывает:

✓ наличие активной инфекции

Что НЕ показывает:

- степень воспаления или повреждение слизистой
- не определяет штамм (CagA, VacA)
- может быть ложноположительным после антибиотиков или ИПП

Когда использовать:

- альтернатива дыхательному тесту
- контроль после лечения (через ≥ 4 недели)



HOLISTICA DOC

Гастроскопия + биопсия (гистология) в нескольких точках желудка

Что показывает:

- ✓ факт наличия *H. pylori* в слизистой
- ✓ степень гастрита, воспаления, атрофии, структурных изменений

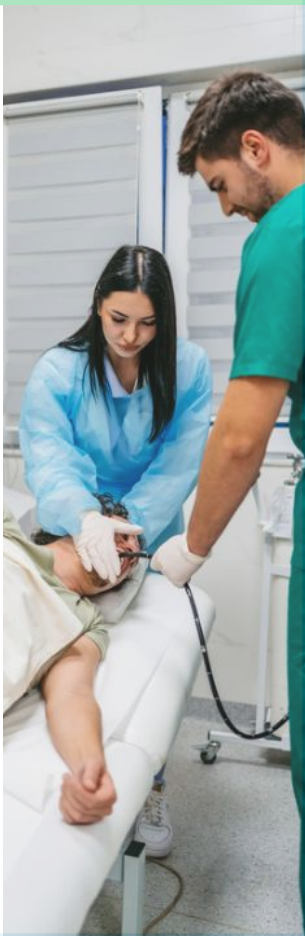
Что НЕ показывает:

- ☐ не определяет устойчивость к антибиотикам (если не делать посев или ПЦР)

Инвазивный метод

Когда использовать:

- людям 45+ при первичном выявлении инфекции
- при подозрении на язву желудка
- если лечение не помогает



HOLISTICA DOC

ПЦР – полимеразная цепная реакция в кале, биоптате слизистой желудка, желудочном соке

Что показывает:

- ✓ патогенность: CagA, VacA
- ✓ мутации устойчивости к антибиотикам

Что НЕ показывает:

- ☐ не даёт полной картины воспаления желудка
- ☐ ДНК может оставаться после смерти бактерии – ложноположительные результаты после лечения

Когда использовать:

- если нужно определить тип и патогенность *H. pylori*
- у пациентов с повторяющимися инфекциями при подозрении на устойчивый штамм



Уреазный тест (быстрый тест в биоптате)

Что показывает:

✓ факт активной инфекции

✓ очень быстрый результат (10–30 минут)

Что НЕ показывает:

☐ не выявляет штаммы и мутации

☐ может быть ложноотрицательным при приёме ИПП или антибиотиков

Когда использовать:

- прямо во время гастроскопии — быстрое подтверждение наличия бактерии



Посев *H. pylori* из биоптата

Что показывает:

✓ живые бактерии *H. pylori*

✓ чувствительность к антибиотикам

Что НЕ показывает:

☐ долгий результат – до 2 недель

☐ может не получиться вырастить культуру бактерий

Когда использовать:

- для подбора точного лечения при неэффективности стандартной терапии

Важно! Перед диагностикой не менее чем за 2 недели нужно отменить ИПП, не менее чем за 4 недели – отменить антибиотики и препараты висмута.

Эрадикация *H. Pylori*

Схема на 10–14 дней:

Антисекреторный препарат (ИПП)	Подавляет кислотность, улучшает действие антибиотиков
Антибиотик № 1 (кларитромицин или амоксициллин)	Уничтожение бактерий
Антибиотик № 2 (например, метронидазол, тинидазол, левофлоксацин)	Для повышения эффективности
Препарат висмута (не всегда)	Дополнительно разрушает мембрану *H. pylori* и защищает слизистую

Эрадикация показана обязательно, когда есть *H. pylori* и при этом есть:



- патогенные штаммы *H. pylori*
- язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки
- атрофический гастрит, кишечная метаплазия, дисплазия слизистой желудка
- MALT-лимфома желудка
- удаление рака желудка (в анамнезе или после операции)
- близкие родственники с раком желудка
- планируемый или текущий приём НПВС, аспирина, антикоагулянтов
- железодефицитная анемия неясного происхождения (особенно если есть гастрит)

HOLISTICA DOC

Когда эрадикация рекомендуется, но не является строго обязательной:

1. Диспепсия (функциональные нарушения пищеварения)
2. Хронический гастрит без осложнений

Если *H. pylori* обнаружена у бессимптомного пациента с нормальным анамнезом (личным и семейным), эрадикация не нужна – в этом случае она может вызвать формирование штаммов, резистентных к антибиотикам.

Решение об эрадикации принимает врач на основании совокупности данных о пациенте.



Влияем на *H. Pylori* **питанием и ЗОЖ**

1. **Гигиена:**
   - мыть руки: перед едой, после туалета, после улицы
   - не пользоваться чужими столовыми приборами, зубными щётками, стаканами
   - обучать детей мыть руки, не пить из чужих бутылок
2. **Безопасная вода:**
   - пить только кипячёную или фильтрованную воду
   - не употреблять воду из-под крана в регионах с сомнительной очисткой



HOLISTICA DOC

Влияем на *H. Pylori* **питанием и ЗОЖ**

3. **Безопасная еда:**
   - избегать немытой зелени, овощей, фруктов
   - есть полностью приготовленное мясо и рыбу, не есть полусырое
   - общепит: чем более простая и знакомая кухня, тем лучше
4. **Избегать совместного использования посуды:**
   - не доедать за детьми, не облизывать ложки, соски и т. д.

Если у одного члена семьи есть *H. pylori* – рекомендуется обследовать и, возможно, пролечить всех!

Что помогает контролировать распространение *H. pylori* в желудке?

- Кислотность желудочного сока
- Физиологичный (не избыточный) дуоденогастральный рефлюкс
- Факторы защиты слизистой желудка



База – в ваших уроках «Еда: какая делает мне хуже, а какая лучше?» и «Правила еды: лайфхаки и кулинарные приемы, чтобы переваривать пищу лучше».

HOLISTICA DOC

Топ продуктов и специй
против *H. pylori*

Как профилактика и дополнение к терапии.

Используйте их по возможности и в соответствии с вашим протоколом.

Специи

- Чеснок
- Куркума
- Имбирь
- Чёрный тмин
- Кардамон
- Корица
- Гвоздика
- Орегано
- Тимьян
- Розмарин
- Фенхель
- Паприка и жгучий красный перец
- Анис



HOLISTICA DOC

Продукты

Брокколи

Проростки брокколи

Мёд манука

Клюква (ягоды или сок)

Облепиха

Капуста белокочанная свежая и квашеная

Оливковое масло

Зелёный чай

Лён

Кефир, йогурт, простокваша (с живыми культурами)

Горькие садовые травы: руккола, одуванчик

Шпинат

Лимон и лайм

Яблочный уксус натурального брожения (в воду)

Ферментированные овощи

Гранат



Черника

Базилик

Тыква

Свёкла

Морковь

Морская капуста

Дополнение к терапии хеликобактера

Штаммы пробиотиков, улучшающие терапию *H. pylori*

- *Lactobacillus rhamnosus, reuteri, acidophilus, casei, johnsonii*
- *Bifidobacterium lactis, bifidum, longum*
- *Saccharomyces boulardii*
- *Bacillus subtilis*







Метаанализ Cochrane (2016): добавление пробиотиков к стандартной терапии повышает успех лечения в среднем на 8–10 %, уменьшает частоту побочных эффектов почти в 2 раза.

Витамины, повышающие эффективность эрадикации

Витамин С

Подавляет рост *H. pylori*, улучшает иммунный ответ. В исследованиях приём 500–1000 мг/сутки в течение 4–8 недель повышал успех эрадикации на 10–12 %.

Обязательно индивидуальный подбор дозы, только после еды. Нельзя при поврежденной слизистой ЖКТ! Лучше выбирать липосомальную форму.

Витамин Е (токоферол)

В дозе 200–400 МЕ/сутки в сочетании с витамином С снижает воспаление слизистой.

Витамин D

Иммуномодуляция, активация противомикробных пептидов, подавление воспаления. Низкий уровень витамина D связан с пониженной эффективностью терапии.

Нутрицевтики, повышающие эффективность эрадикации

«Растворители» биоплёнок: монолаурин (лауриновая кислота), АЦЦ, «Вобэнзим» (см. урок «Вздутие ч. 3»).

Масло орегано – антибиотическое, противогрибковое, антипаразитарное действие. Приём: 1 капсула/день после еды.

Обволакивающие средства с активностью против *H. Pylori:*

- солодка (в форме отвара или деглицирризированного экстракта – DGL) – обволакивающее и антибактериальное действие. Приём: 1 пастилка 2 раза в день за 20 минут до еды
- мастиковая смола (mastic gum) – антисептическое, антибактериальное, противогрибковое действие. Приём: по 1 капсуле (500 мг) 2 раза в день

Сочетаем эрадикацию и поддерживающие меры

До начала эрадикации

Восполняем витамин D.

За 1–2 недели до старта эрадикации начинаем принимать 1 из «растворителей» биоплёнок.

Во время эрадикации – 14 дней

Одновременно с приёмом ИПП, антибиотиков, висмута:

- витамин C + витамин E (если нет противопоказаний со стороны слизистой)
- «Хелинорм» (Pylopass), сахаромицеты буларди, «Бактистатин»
- «растворитель» биоплёнок



HOLISTICA DOC

После окончания эрадикации – 3–4 недели

- Если есть повреждения слизистой: солодка или мастиковая смола
- Масло орегано (если нет активного воспаления ЖКТ)
- «Хелинорм» (Pylopass)
- Фитосоставы из вашего протокола: пищеварительный, для желчеоттока

При необходимости – подключаем дополнительные меры по заживлению слизистой (см. урок «Заживляем слизистую: дополнительные меры»).

Через 4–6 недель – повторный контроль анализов на *H. pylori:* уреазный дыхательный тест, анализ кала методом ПЦР.